

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

garenoxacin 200mg (제니낙스정200mg, 동아제약)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1정 중 garenoxacin mesylate 253.53mg(as garenoxacin 200mg)

☐ 효능 효과 :

- 유효균종: 이 약 가레녹사신에 감수성이 있는 포도상구균속, 연쇄구균속, 폐렴구균 (페니실린내성구균 포함), 모락셀라(브란하멜라)·카타랄리스, 대장균, 클레브시엘라속, 엔테로박터속, 인플루엔자균, 레지오넬라 뉴모필라, 클라미디아, 마이코플라즈마
- 적응증: 지역사회 획득성 폐렴, 만성기관지염의 급성 악화, 급성 세균성 부비강염

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2011년 제1차 약제급여평가위원회 : 2011년 1월 20일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2010년 3월 18일¹⁾

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “지역사회 획득성 폐렴, 만성기관지염의 급성 악화, 급성 세균성 부비강염”에 허가받은 약제로, 신청품과 대체약제간 효과차이가 있다고 보기 어렵고, 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “지역사회 획득성 폐렴, 만성기관지염의 급성 악화, 급성 세균성 부비강염”에 허가받은 fluoroquinolone계 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 유사 적응증에 허가받은 ciprofloxacin, levofloxacin 등이 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 호흡기감염의 원인균에 효과적인 fluoroquinolone계 항생제임.²⁾
- 신청품은 C6 위치에 fluorine이 결합되고 C8 위치에 difluoromethyl기가 치환된 새로운 des-F(6)-quinolone으로, 다제 내성 S. pneumoniae에 우수한 항균효과(MIC90, 0.06μg/mL)를 보임.
- 신청품은 기존의 fluoroquinolone계 항생제와 유사한 효과 및 장단점을 나타낼 것으로 보여지며³⁾⁴⁾, 관련 가이드라인에는 제시되어 있지 않음.
- 신청품은 타 유사 약제와 비교시 특징점이 없으므로, 등재시 유사약제와 동일한 수준(2차)으로 급여인정 가능함.⁵⁾
- 세균성 폐렴 환자 232명을 대상으로 무작위배정, 이중맹검, levofloxacin 대조, 비열등성 3상임상 결과, 투여 종료시(10일 투여) 신청품군의 유효율은 99.1%, levofloxacin군 94.3%로(PPS 분석), levofloxacin과 비열등함.(유효율 차이의 95% CI: -0.3~10.0%)⁶⁾
- 세균학적 효과의 평가가 가능했던 99례에 대한 투여 종료시의 균소실율은 두군 모두 100%이나, 투여 종료 7일후의 균소실율은 신청품군 100%(50례), levofloxacin군 86.8%(33/38례)로 5례에서 재검출됨.(균소실율 차이의 95% CI: 2.4~23.9%)
- 시험약에 의한 이상반응 및 임상검사치 이상의 발생률은 신청품군 35.6%(48/135례), levofloxacin군 27.1%(32/118례)로 두군간의 차이가 인정되지 않음.(발생률 차이의 95% CI: -2.9~19.8%)

○ 비용 효과성

- fluoroquinolone계 항생제들은 대부분 신청품의 허가사항인 호흡기계 감염증에 사용 가능하나⁷⁾, ■■■■■ fluoroquinolone 중 2차 약제인 fleroxacin, lomefloxacin, pefloxacin⁸⁾, sparfloxacin, tosufloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, gemifloxacin, moxifloxacin을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품은 세균성 폐렴에 대한 levofloxacin과의 직접비교 임상시험 결과 비열등하였으며, 타 fluoroquinolone과의 직접비교 임상시험자료는 검색되지 않았으나 신청품과 대체약제간 효과차이가 있다고 보기 어려우며²⁾³⁾, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로 대체약제의 가중일일투약비용인 ■■■원 보다 저렴하므로 비용효과적임.

○ 재정 영향⁹⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹¹⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 기존약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원으로 절감될 것으로 예상됨¹²⁾

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 일본에 등재되어있음.

Reference

- 1) 기심의(2010년 제4차 약제급여평가위원회) 당시 심의일
- 2) 대한감염학회, 항생제의 길잡이 3판
- 3) Mandell: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th ed.
- 4) 대한화학요법학회■■■■, 대한감염학회■■■■
- 5) 중앙심사평가조정위원회 2010.3.18
- 6) Hiroyuki Kobayashi et.al. Clinical phase III comparative study on garenoxacin versus levofloxacin in patients with bacterial pneumonia, Japanese Journal of Chemotherapy 2007 Oct. vol.55 S-1 127-43
- 7) 기등재 퀴놀론계 항생제는 enoxacin, norfloxacin, ofloxacin, fleroxacin, lomefloxacin, pefloxacin, sparfloxacin, tosufloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, gemifloxacin, moxifloxacin, balofloxacin의 13성분이며, 이 중 balofloxacin은 요로감염증, 골반내감염, 자궁경관염에만 허가됨.
- 8) ■■■■
- 9) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 10) 제약사 제출 예상사용량(1차년도: ■■■정, 2차년도: ■■■정, 3차년도: ■■■정)
- 11) 절대재정소요금액 = 제약사 제출 예상사용량 x 신청약가
- 12) 재정증감액 = (대체약제의 가중일일투약비용-신청품의 일일투약비용) x (제약사 제출 예상사용량/일일투여 정제수)주1
주1) 제약사 제출 예상사용량 기준을 일일투약정제수(■■■)로 보정한 투약일수